

TEMA 9.5 • RESPIRATORIO

Síndrome bronquial obstructivo

PERFIL EUNACOM 1.05.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO)** es una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencia y atención primaria durante los meses de invierno en Chile. Se define como un cuadro clínico caracterizado por inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias bajas en niños, generalmente de origen infeccioso.

Definiciones Clave y Diferenciación

Es fundamental distinguir entre los diferentes términos clínicos que suelen confundirse en la práctica diaria:

TABLA 9.5.1: TÉRMINO VS DEFINICIÓN

TÉRMINO	DEFINICIÓN	EDAD TÍPICA
Bronquiolitis	Primer episodio de SBO en el lactante.	< 1 - 2 años
SBO (Agudo)	Cuadro agudo de obstrucción bronquial (sinónimo de crisis obstructiva).	Lactantes y preescolares
SBO Recurrente (SBOR)	3 o más episodios de SBO en un periodo de 12 meses.	< 2 años
Asma	Obstrucción bronquial recurrente con alta probabilidad de cronicidad.	> 2 - 6 años

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del inicio del cuadro: La mayoría de los cuadros de SBO comienzan como una infección respiratoria alta. Los virus (como el **VRS**) infectan inicialmente la vía aérea superior (nasofaringe), provocando rinorrea y fiebre. Posteriormente, el virus desciende hacia la vía aérea inferior, causando inflamación del epitelio bronquial, edema de la mucosa y aumento de secreciones, lo que genera la obstrucción característica.

Etiología: El rol de los virus

La causa principal del SBO es viral en la gran mayoría de los casos.

- **Virus Respiratorio Sincicial (VRS):** Es el agente más importante, responsable de aproximadamente el **80% de los casos**.
- **Metapneumovirus:** Ha emergido como la segunda causa más frecuente en Chile en los últimos años.
- **Otros virus:** Virus Para-influenza, Adenovirus, Influenza y Rinovirus.
- **Bacterias:** Aunque menos frecuentes, el *Mycoplasma pneumoniae* puede simular perfectamente una crisis obstructiva o un cuadro de asma, especialmente en niños mayores.

Cuadro Clínico: Pilares del Diagnóstico

El diagnóstico del SBO es **estrictamente clínico**. No se requieren exámenes de laboratorio o imágenes para confirmar la presencia del síndrome, aunque pueden ser útiles para descartar complicaciones (como neumonía).

La clínica se divide en dos grandes grupos de signos:

1. Signos de Obstrucción

Indican que el flujo de aire está dificultado por el estrechamiento de los bronquios: - **Sibilancias:** El signo más característico a la auscultación (y a veces audible a distancia). - **Roncus:** Por presencia de secreciones. - **Hiperinsuflación:** Aumento del diámetro anteroposterior del tórax ("tórax en tonel" funcional). - **Espiración prolongada.**

2. Signos de Dificultad Respiratoria

Indican el esfuerzo que realiza el paciente para compensar la obstrucción: - **Taquipnea:** Aumento de la frecuencia respiratoria (primer signo de alarma). - **Retracción de musculatura accesorio:** Puede ser subcostal, intercostal o tiraje cervical. - **Cianosis:** Signo de hipoxemia severa (tardío). - **Aleteo nasal.**

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perlas de Diagnóstico Diferencial: - Si el niño tiene **menos de 2 años** y es su primer episodio: **Bronquiolitis**. - Si el niño tiene **más de 2-6 años** y presenta episodios recurrentes: Sospechar **Asma**. - La mayoría de los niños con SBOR (recurrente) dejarán de tener síntomas al crecer; los niños con asma suelen persistir con síntomas a lo largo de su vida.

Evaluación de la Severidad: Score de Tal

Para objetivar la gravedad de la crisis y guiar el tratamiento, se utiliza el **Score de Tal**. Este score evalúa 4 parámetros clínicos:

- **Frecuencia Respiratoria** (ajustada por edad).
- **Sibilancias.**
- **Cianosis.**
- **Uso de musculatura accesorio** (retracción).

Cada parámetro se puntúa de 0 a 3. Un puntaje mayor indica mayor gravedad de la crisis.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Signos de Extrema Gravedad: Más allá del Score de Tal, existen signos que indican una falla respiratoria inminente o agotamiento, lo que requiere manejo de urgencia inmediata: - **Compromiso de conciencia:** Somnolencia, irritabilidad extrema o letargo. - **Agotamiento muscular:** El niño deja de hacer esfuerzo respiratorio porque ya no tiene energía (puede preceder al paro respiratorio). - **Silencio auscultatorio:** La obstrucción es tan severa que no pasa aire, por lo que dejan de escucharse sibilancias. - **Saturación de oxígeno baja:** Especialmente si no mejora con oxígeno suplementario.

Evolución hacia el Asma

Una de las grandes dudas en la práctica clínica es cuándo dejar de llamar a un niño "SBO Recurrente" y empezar a llamarlo "Asmático".

- **< 2 años:** La probabilidad de que sea asma es baja; la mayoría son "sibilantes transitorios".
- **2 a 3 años:** Es una zona gris donde el riesgo de asma empieza a aumentar según los antecedentes (atopia, herencia).
- **> 6 años:** Si hay obstrucción recurrente, el diagnóstico es **Asma** con alta certeza.

Es fundamental recordar que, independientemente del nombre del diagnóstico, el **manejo clínico inicial** de una crisis obstructiva en un paciente con SBOR o en uno con Asma es prácticamente el mismo (basado en broncodilatadores y corticoides según sea el caso).

- *Próximos temas recomendados:*
- **Manejo del SBO Agudo**
- **Score de Tal en detalle**
- **Oxigenoterapia en Pediatría**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Lactante de 8 meses, previamente sano, consulta por cuadro de 3 días de evolución con rinorrea, tos y fiebre baja. Hoy agrega dificultad respiratoria con sibilancias espiratorias bilaterales y retracción subcostal. Es su primer episodio de estas características. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndrome bronquial obstructivo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La bronquiolitis es el primer episodio de SBO en un lactante menor de 1-2 años
- El SBO combina signos de obstrucción (sibilancias, roncus, hiperinsuflación) con dificultad respiratoria (taquipnea, cianosis, tiraje)
- El SBO recurrente se define como 3-4 o más episodios de SBO en 12 meses en un menor de 2 años
- El VRS causa el 80% de los SBO; metaneumovirus es el segundo en frecuencia en Chile
- El diagnóstico del SBO es absolutamente clínico
- La severidad se evalúa con el score de Tal (taquipnea, sibilancias, musculatura accesoria, cianosis)
- Después de los 2 años la obstrucción recurrente se reclasifica como asma
- El compromiso de conciencia y el agotamiento muscular son signos de extrema gravedad
- El manejo del SBO recurrente y del asma es el mismo

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO)**PREGUNTA 1**

Lactante de 8 meses, previamente sano, consulta por cuadro de 3 días de evolución con rinorrea, tos y fiebre baja. Hoy agrega dificultad respiratoria con sibilancias espiratorias bilaterales y retracción subcostal. Es su primer episodio de estas características. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?

- A)** Asma bronquial
- B)** Bronquiolitis
- C)** Síndrome bronquial obstructivo recurrente
- D)** Neumonía bacteriana
- E)** Laringitis obstructiva

PREGUNTA 2

Niño de 14 meses con antecedente de 4 episodios de sibilancias en los últimos 10 meses, todos tratados en urgencias con salbutamol. Actualmente asintomático. ¿Cuál es el diagnóstico más apropiado?

- A)** Bronquiolitis recurrente
- B)** Asma bronquial
- C)** Síndrome bronquial obstructivo recurrente
- D)** Infección respiratoria alta recurrente
- E)** Fibrosis quística

PREGUNTA 3

¿Cuál es el agente etiológico más frecuente del síndrome bronquial obstructivo en lactantes?

- A)** Metaneumovirus
- B)** Adenovirus
- C)** Virus parainfluenza
- D)** Virus respiratorio sincial
- E)** Mycoplasma pneumoniae

RESUMEN: SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO

El síndrome bronquial obstructivo (SBO) es un cuadro frecuente en pediatría, especialmente durante los meses de invierno. Es fundamental diferenciar los distintos conceptos asociados. La bronquiolitis corresponde al primer episodio de SBO en un lactante menor de 2 años (o menor de 1 año según algunos autores chilenos), generalmente causada por el virus respiratorio sincicial (VRS) que inicialmente infecta la vía aérea superior antes de progresar a la vía inferior. El SBO es un síndrome que combina signos de obstrucción bronquial (sibilancias, roncus, hiperinsuflación, aumento del diámetro anteroposterior) con signos de dificultad respiratoria (taquipnea, cianosis, uso de musculatura accesoria subcostal, intercostal o cervical). La crisis obstructiva o bronquitis obstructiva se usa como sinónimo de un SBO agudo. El SBO recurrente se define como 3-4 o más episodios de SBO en 12 meses en un menor de 2 años. La causa principal del SBO es el VRS en un 80% de los casos. Otros agentes incluyen metaneumovirus (segundo en frecuencia en Chile), virus parainfluenza, adenovirus y *Mycoplasma pneumoniae*. El diagnóstico es clínico: un niño con dificultad respiratoria y sibilancias configura un SBO. La severidad se evalúa mediante el score de Tal, que mide taquipnea, sibilancias, uso de musculatura accesoria y cianosis. Después de los 2 años, la obstrucción recurrente se reclasifica como asma. Entre los 2 y 6 años lo más probable es que evolucione como asma, y después de los 6 años es prácticamente seguro. La diferencia pronóstica es que la mayoría de los SBO recurrentes no dejarán síntomas crónicos, mientras que el asma tiende a persistir con distintos grados de intensidad a lo largo de la vida. Sin embargo, el manejo del SBO recurrente y del asma es el mismo.